

TUMORI CUTANATE BENIGNE



AGENDA

- KERATOZA SEBOREICĂ
- HEMANGIOM/ ANGIOM
- NEVI MELANOCITARI



KERATOZA SEBOREICĂ

- 40 – 50 ani
- Papule bine delimitate, cu suprafața netedă sau verucoasă, de culoare gălbuie, brună sau culoarea pielii; mm – cm; câteva – sute
- Evoluție cronică, benignă, devenind în timp mai numeroase și mai intens pigmentate.



KERATOZA SEBOREICĂ

- Localizare - trunchi, față (regiunile seboreice), gât, abdomen, pliuri axilare si inghinale, fețele extensorii ale antebrațelor

Tratament - crioterapie,
electrocoagulare superficială,
chiuretare,
fotocoagulare Laser,
dermabraziune





HEMANGIOAME



- Tumori benigne vasculare,
- prezente la naștere sau care apar imediat după naștere
- Fază de creștere rapidă post-natală (3 și 9 luni) - faza involutivă (2 și 10 ani)
- Clinic: formațiune tumorală bine delimitată, eritematoasă, de nuanță “roșu-aprins”



HEMANGIOAME

- Tratament:
- 70% cazuri – regresie spontană – atitudine conservativă
- Crioterapie, compresie, laserterapie, sclerozare
- Sistemic – corticoterapie, β -blocante



ANGIOAME SENILE (CHERRY ANGIOMA)

- Cea mai frecventă proliferare capilara
- Leziuni *in dom*, roșii-violacee, câțiva mm, la nivelul trunchiului, multiple
- Debut – după 30 ani



ANGIOAME SENILE (CHERRY ANGIOMA)

- Tratament:
- Crioterapie/ lasert terapie
- cauterizare, excizie
- estetic

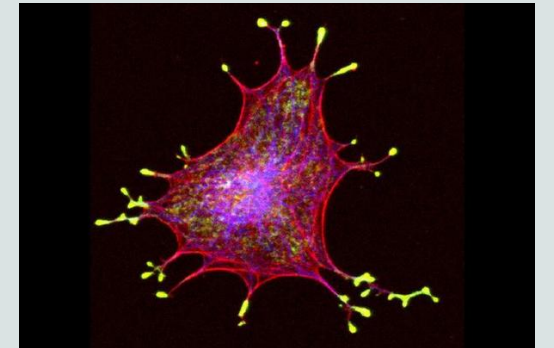


NEVII MELANOCITARI

- Proliferarea melanocitelor:

epiderm / derm

- Congenitali / dobândiți



cellimagelibrary.org

NM CONGENITALI

- Prezenți la naștere
- Mici (sub 1,5 cm), mijlocii (1,5-20 cm) și giganți (peste 20 cm)
- Placard hiperpigmentat, cu o colorație neuniformă, de la **brun**-deschis la negru, suprafața plană sau reliefată, papulo-nodulară, verucoasă, uneori cu fire de păr pe suprafața sa
- Giganți – risc crescut de transformare malignă - URMĂRIRE





NEVII MELANOCITARI CONGENITALI

- Placard hiperpigmentat, cu o colorație neuniformă, de la **brun**-deschis la negru, suprafața plană sau reliefată, papulo-nodulară, verucoasă, uneori cu fire de păr pe suprafața sa
- Tratament :
- Supraveghere sau
- Excizie



NEVII MELANOCITARI DOBÂNDIȚI

- Apar pe parcursul vieții – copii, tineri
- Factor genetic, expunere solară
- Pete/papule pigmentare, rotund-ovalare, cu contur regulat, brun deschis – negru, câțiva mm – cm
- Localizare – piele, mucoase
- Comuni / atipici
- Examinare clinică, dermatoscopică
- Supraveghere – toată viața; nu se recomandă excizia profilactică





NEVUL MELANOCITAR ATIPIC

Regula **ABCDE**

- **A**simetrie
- **B**order (margine)
- **C**olour (culoare)
- **D**iameter > 6 mm (diametru)
- **E**levation – evolution (elevație – evoluție)

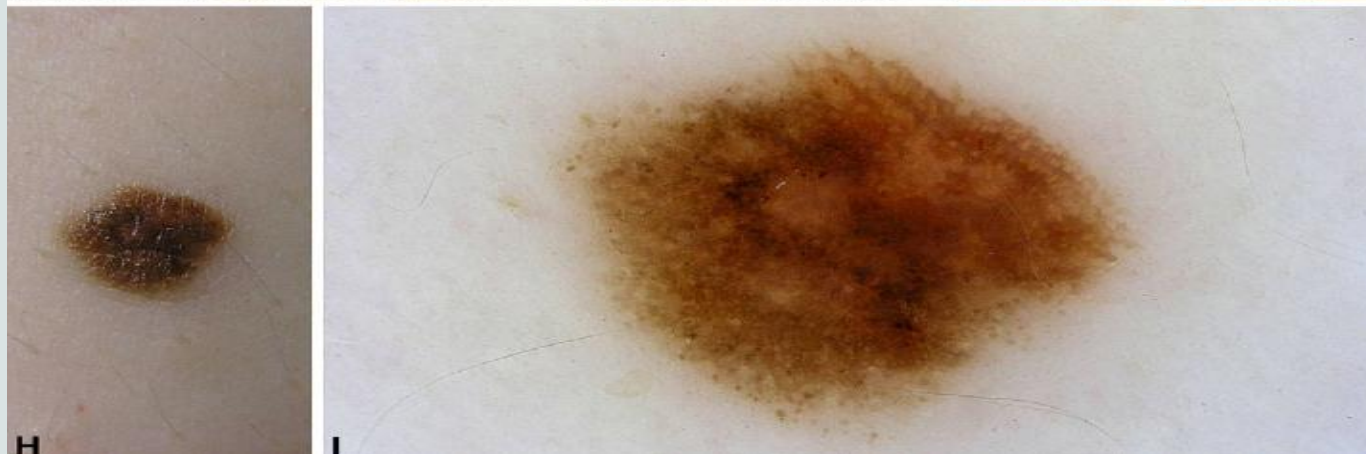
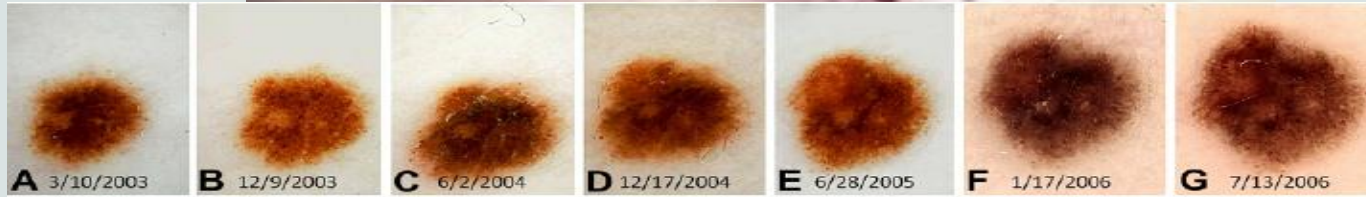
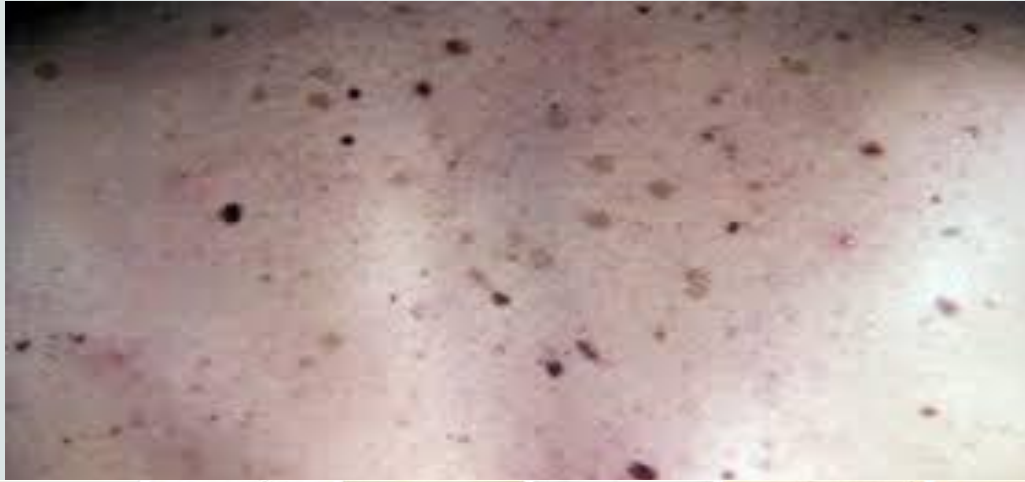
Supraveghere

Fotoprotecție!

Excizia profilactică?



SINDROMUL NEVILOR ATIPICI



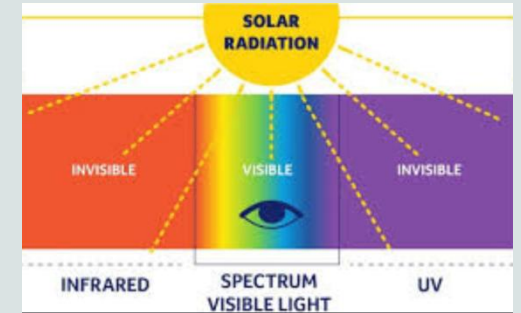
LEZIUNI CUTANATE PREMALIGNE



KERATOZELE ACTINICE

Actinic= (Despre radiații) Capabil să producă reacții (foto) chimice.

(dexonline.ro)

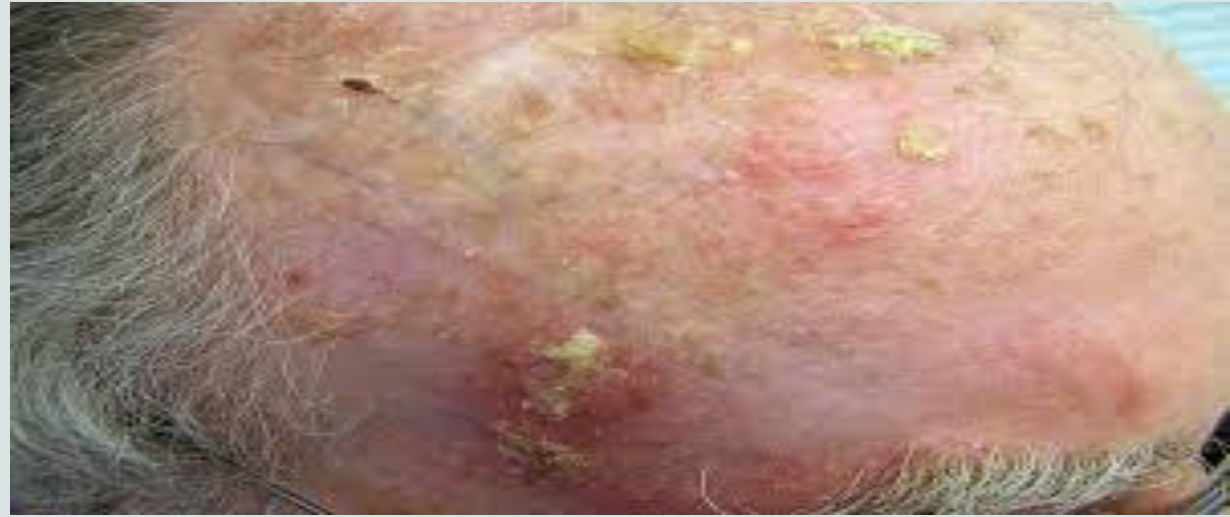


- M>F, vârstă medie, **fototip deschis**, expunere **cronică** la soare
- Clinic: Leziuni rotunde-ovalare, eritematoase, brun-deschise, acoperite de o **scuamă hiperkeratozică** aderentă; dimensiune<1cm
- Leziuni izolate sau multiple – față, tâmples, pavilion auricular, gât, dosul mâinilor, gambe, scalp

pe zone fotoexpuse!

- EHP – keratinocite atipice, diskeratotice
- Evoluție – dispariție spontană (rar); riscul de carcinom scuamos 1%





KERATOZELE ACTINICE

Prevenție –fotoprotecție eficientă UVB/UVA

Tratament:

- **Crioterapie**
- **Sau** alte măsuri distructive locale, precum:
- Imiquimod, 5-Fluorouracil
- Retinoizi topici
- Peeling facial
- Terapie laser
- Terapie fotodinamică



CHEILITA ACTINICĂ

- Afectează buza inferioară
- Variații de culoare, scuame fine, fisuri, papulă sau placă keratotică
- Risc de transformare in carcinom scuamos!



LEUCOPLAZIA

- Placă/leziune albă la nivelul orofaringelui
- Termen descriptiv clinic, diagnosticul definitiv e histologic
- Placă albă, care nu poate fi îndepărtată, nu poate fi încadrată într-o categorie distinctă și poate fi premalignă/malignă





ELISABETA.CANDREA@UMFCLUJ.RO